

Đặt Ống Thông Bàng Quang Trên Xương Mu

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Những điều cần biết trước thủ thuật

Ống thông bàng quang trên xương mu — còn gọi là ống thông bụng dưới hoặc “SPT” — là một ống mềm dẫn nước tiểu ra khỏi bàng quang qua một lỗ nhỏ ở bụng dưới, ngay trên xương mu, thay vì qua niệu đạo. Tờ thông tin này giải thích lý do đặt ống, cách chuẩn bị và những gì sẽ xảy ra.

Về thủ thuật này

Bàng quang chứa nước tiểu. Khi nước tiểu không thể thoát ra theo đường thông thường — hoặc cần để niệu đạo nghỉ ngơi hay tránh dùng niệu đạo — một ống thông có thể được đặt trực tiếp vào bàng quang qua bụng dưới. Vì không đi qua niệu đạo, ống thông trên xương mu (SPT) thường thoải mái hơn khi dùng lâu dài và ít gây tổn thương niệu đạo hơn so với ống thông thông thường.

Nhóm chăm sóc của bạn có thể đề nghị đặt SPT để:

- Dẫn lưu bàng quang khi bạn không thể tự đi tiểu được
- Để niệu đạo nghỉ ngơi hoặc bảo vệ niệu đạo sau phẫu thuật hoặc chấn thương
- Dẫn lưu lâu dài thoải mái hơn (ví dụ, khi có bệnh lý bàng quang do thần kinh)
- Tránh kích ứng do ống thông qua niệu đạo dài ngày gây ra
- Cho phép sinh hoạt tình dục bình thường và “thử bỏ ống” (có thể kẹp ống để kiểm tra khả năng đi tiểu)

Có an toàn không?

Có. Đây là thủ thuật phổ biến và nhìn chung an toàn. Để đảm bảo an toàn, bàng quang được bơm đầy nước để nổi lên sát thành bụng, và nhóm chăm sóc thường dùng siêu âm và/hoặc camera nhỏ để hướng dẫn đưa ống vào tránh xa ruột. Hầu hết các vấn đề — chảy máu nhẹ, khó chịu nhẹ, hoặc co thắt bàng quang — đều nhẹ và nhanh hết. Hãy báo cho nhóm chăm sóc nếu bạn đã từng phẫu thuật bụng hoặc vùng chậu trước đây, vì điều đó cần được chú ý đặc biệt.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Trên xương mu (Suprapubic)

Vùng bụng dưới ngay trên xương mu — nơi ống thông đi ra ngoài.

Bàng quang

Cơ quan chứa nước tiểu cho đến khi bạn đi tiểu.

Ống thông (Catheter)

Ống mềm dẫn nước tiểu ra ngoài. SPT dẫn qua bụng thay vì niệu đạo.

Niệu đạo

Ống thông thường dẫn nước tiểu ra khỏi cơ thể. SPT không đi qua niệu đạo.

Thuốc tê tại chỗ

Thuốc gây tê vùng da để không gây đau tại chỗ đặt ống.

An thần / Gây mê

Thuốc giúp bạn thư giãn hoặc ngủ (gây mê toàn thân) trong khi làm thủ thuật.

Siêu âm / Camera

Công cụ (hình ảnh sóng âm, hoặc camera nhỏ trong bàng quang) để hướng dẫn đặt ống an toàn.

Co thắt bàng quang

Cơn co thắt đột ngột của bàng quang — thường gặp sau thủ thuật và có thể điều trị được.

CÓ ĐAU KHÔNG? Tùy thuộc vào cách tiếp cận: một số ca dùng thuốc tê kết hợp an thần; nhiều ca được thực hiện dưới **gây mê toàn thân hoặc gây tê tủy sống**, nghĩa là bạn ngủ hoặc không cảm giác đau. Nhóm chăm sóc sẽ cho bạn biết phương pháp nào sẽ được dùng. Sau thủ thuật, có thể có cảm giác đau âm ỉ hoặc co thắt bàng quang — đây là bình thường. Thủ thuật mất khoảng 15–30 phút.

Cách chuẩn bị (Trước thủ thuật)

- **Đến với bàng quang đầy nếu được yêu cầu** — giúp đặt ống an toàn hơn. Nhóm chăm sóc có thể yêu cầu bạn uống nước và nhịn tiểu, hoặc sẽ bơm đầy bàng quang khi bắt đầu.
- **Tuân theo hướng dẫn nhịn ăn** — nếu bạn sẽ được an thần hoặc gây mê toàn thân, bạn có thể được yêu cầu không ăn uống trong vài giờ trước.
- **Nhờ người đưa về nhà** nếu bạn sẽ được an thần.

Hãy báo cho nhóm chăm sóc trước nếu bạn:

- Đã từng **phẫu thuật bụng hoặc vùng chậu** — mô sẹo có thể làm thay đổi đường đặt ống an toàn nhất
- Đang dùng **thuốc làm loãng máu** hoặc có vấn đề chảy máu — thường phải ngừng trước thủ thuật
- Có thể **đang mang thai**, có nhiễm trùng, hoặc dị ứng thuốc tê hoặc latex

Quá trình thực hiện thủ thuật

- 1 Bạn được đặt tư thế và gây tê/gây mê — thuốc tê kết hợp an thần, hoặc gây mê toàn thân hay gây tê tủy sống. Sau đó bụng dưới được làm sạch và chuẩn bị.
- 2 Bàng quang được bơm đầy dịch (nếu chưa đầy) để nổi lên sát thành bụng, tránh xa ruột.
- 3 Được hướng dẫn bằng siêu âm và/hoặc camera nhỏ trong bàng quang, nhóm chăm sóc tạo một vết rạch nhỏ ngay trên xương mu và đưa ống vào bàng quang.
- 4 Một bóng nhỏ được bơm căng bên trong bàng quang để giữ ống cố định, sau đó ống được nối với túi dẫn lưu.

Sau thủ thuật

- Nước tiểu chảy vào túi dẫn lưu, và nhóm chăm sóc sẽ **hướng dẫn bạn cách chăm sóc ống và vùng da xung quanh** trước khi về nhà.
- Đau âm ỉ nhẹ, co thắt bàng quang, hoặc **nước tiểu có một ít máu** trong một hoặc hai ngày đầu là bình thường.
- **Lần thay ống đầu tiên do nhóm chăm sóc thực hiện**, khoảng 4–6 tuần sau. Nếu ống bị tuột ra, hãy liên hệ ngay với nhóm chăm sóc — đường hầm có thể đóng lại trong vài giờ.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc hoặc đến cơ sở y tế nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh
- Ống **bị tuột ra** hoặc ngừng dẫn lưu (không có nước tiểu trong túi)
- Đau bụng ngày càng tăng, sưng, hoặc chảy máu nhiều
- Nước tiểu đục hoặc có mùi hôi (dấu hiệu nhiễm trùng)

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. SPT dẫn nước tiểu từ bàng quang qua một lỗ nhỏ ở bụng dưới, không đi qua niệu đạo — thường thoải mái hơn khi dùng lâu dài.
2. Chuẩn bị: đến với bàng quang đầy nếu được yêu cầu, nhịn ăn theo hướng dẫn, nhờ người đưa về nếu được an thần, và báo cho nhóm chăm sóc về tiền sử phẫu thuật bụng, thuốc làm loãng máu, hoặc khả năng mang thai.
3. Thủ thuật thực hiện dưới gây tê/an thần hoặc gây mê toàn thân. Nhóm chăm sóc hướng dẫn cách chăm sóc ống và thực hiện thay ống lần đầu sau 4–6 tuần.